UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

GUIA DE ENTREGABLE N°3

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

Quezada Ponciano, Nadya Lyz

Peñaloza Díaz, Matias Alejandro

Silva Avileno, Fabiana Valery

Palacin Hilario, Jeanpierre

Ramirez Rodriguez, Alexandra

Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

a) Caso de referencia
b) Perfil funcional
c) Mapa de actividades críticas
d) Barreras y facilitadores
e) Mapa de dolor
f) Expectativas del usuario
g) Referencias bibliográficas

a) Caso de referencia

Caso de referencia 1.
Un caso clínico similar es el de un hombre afroamericano de 39 años que sufrió una herida por arma de fuego en el cuello derecho. Presentó fracturas en C6, C7 y T1, sospecha de lesión de la arteria vertebral derecha y una lesión medular completa C4, clasificada como ASIA A. Durante la hospitalización desarrolló una fuga persistente de líquido cefalorraquídeo, por lo que fue tratado con drenaje ventricular externo debido a la obstrucción del canal espinal en C6/C7. Posteriormente recibió manejo quirúrgico complementario, con resolución de la fuga, aunque con recuperación neurológica limitada. [1]

Este caso es relevante porque comparte elementos importantes con el caso presentado: traumatismo medular cervical por proyectil, déficit neurológico completo y compromiso anatómico cercano a C7. Aunque no es idéntico, permite analizar la gravedad de la lesión, las complicaciones asociadas y la importancia del pronóstico funcional, especialmente en relación con la prevención y tratamiento de complicaciones.

Caso de referencia 2.
Otro caso corresponde a un hombre de 34 años con lesión medular cervical por accidente vehicular, inicialmente clasificado como C5 ASIA A y luego ASIA B. Conservaba movimientos en hombros, codos y muñeca, pero presentaba una limitación importante en la función voluntaria de la mano. Aun así, podía realizar algunas actividades con apoyo, como autocateterización y conducción. Tras una transferencia nerviosa, mejoró la flexión del pulgar y los dedos, logrando mayor facilidad para alimentarse y manipular objetos.[2]

Este caso es útil porque se asemeja al perfil funcional de miembros superiores del caso presentado. Muestra que, en una lesión medular cervical, no basta con definir el nivel neurológico, sino que también debe evaluarse cuánto contribuyen los movimientos conservados a la independencia en actividades de la vida diaria. Por ello, resalta la importancia del autocuidado y la autonomía funcional.

Caso de referencia 3.
Un tercer ejemplo es el caso de Peter, un hombre de 20 años con tetraplejia sub C6, ASIA B, secundaria a fractura vertebral de C5 por accidente automovilístico. Durante la rehabilitación presentó dificultades para manejar la silla de ruedas eléctrica, realizar transferencias y cumplir su rutina diaria, debido al escaso uso funcional de la mano. Aunque mostró cierta mejoría, no alcanzó metas funcionales importantes.[3]

Este caso es relevante porque pone énfasis en cómo las limitaciones motoras afectan la vida diaria. Las dificultades en silla de ruedas, transferencias y rutina cotidiana se relacionan directamente con las metas del caso presentado, como la independencia en silla de ruedas, la semi independencia en actividades de la vida diaria y la mayor autonomía funcional.

b) Perfil funcional

Para poder entender el perfil funcional de nuestro paciente lo dividiremos en 4 factores importantes:
-El estado motoro y su movilidad: Debido a los sucesos el paciente presenta una movilidad activa disminuida en los miembros superiores, con una fuerza muscular de nivel C5 conservada que se reduce a (4/4) en los niveles C6-C8 y a (4/3) en T1. En los miembros inferiores, la movilidad activa es nula y la fuerza muscular es inexistente (0/0) en los niveles L2-S1. Asimismo, se observa un incremento del tono muscular en las extremidades inferiores con predominio distal y una leve disminución de los rangos articulares pasivos, afectando principalmente a las rodillas.

-El estado sensorial : Notablementee la sensibilidad superficial conservada se encuentra hasta el nivel dermatoma C8 ,ademas el impacto de la lesión es una ‘ASIA A ‘ completa , no existe una preservacion de su funcionamiento motor ni sensitivo en los segmentos sacros mas bajos.
-Nivel de dependencia: En las AVD se busca como meta que el paciente alcance la independencia o semi-independencia debido a la evidente ayuda que requiere , un factor del que no se debe evadir es el control de esfinteres ya que necesita una reduccion esfinteriana indicando una total falta de control.
*-Factores contextuales:*El paciente presenta una movilidad activa disminuida en los miembros superiores , manteniendo una fuerza muscular íntegra en el nivel C5 (5/5) que se reduce levemente en los segmentos C6-C8 (4/4) y T1 (4/3). En contraste, los miembros inferiores muestran una ausencia total de movilidad activa y una fuerza muscular nula (0/0) en los niveles L2-S1 , cuadro que se acompaña de espasticidad con predominio distal y una ligera limitación en los rangos articulares pasivos, afectando principalmente a las rodillas.[4]

c) Mapa de actividades críticas

Figura 1. “Mapa de actividades críticas” https://canva.link/dij0fsyuq4j12pu

d) Barreras y facilitadores

En pacientes con lesión medular, las barreras que se relacionan son principalmente con factores ambientales, sociales y del sistema de salud. Entre ellas destacan la falta de acceso a servicios comunitarios y rehabilitación, la fragmentación en la continuidad del cuidado, y la escasa información o capacitación tanto del paciente como de su familia. Asimismo, factores personales como baja motivación o dificultades de adaptación, junto con limitaciones del entorno como una infraestructura no accesible, reducen la independencia y la reintegración social del individuo.[5]

Por otro lado, los facilitadores incluyen el acceso oportuno a los servicios de salud y rehabilitación, así como el apoyo social y familiar, ya que cumplen un rol clave en la recuperación. La educación durante la rehabilitación, el desarrollo de habilidades de autocuidado y el afrontamiento positivo

permiten mejorar la autonomía del paciente de la mejor manera. Además, la disponibilidad de recursos comunitarios y la continuidad del cuidado favorecen la adaptación funcional y la calidad de vida.[6]

En conjunto, la evidencia indica que la funcionalidad en personas con lesión medular no depende únicamente del daño neurológico, sino de la interacción entre factores personales y contextuales. La reducción de estas barreras y el fortalecimiento de facilitadores como por ejemplo el acceso a recursos, la educación y el apoyo social son fundamentales para optimizar la rehabilitación y promover la participación activa del paciente en la sociedad.

e) Mapa de dolor

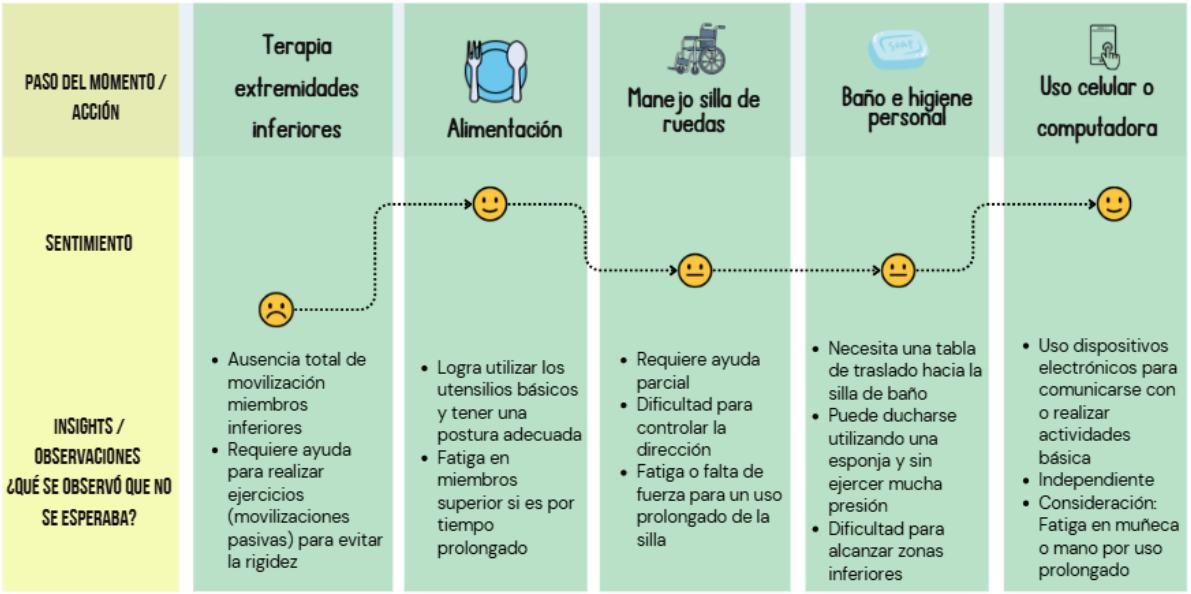

Figura 2 "Mapa de dolor"

f) Expectativas del usuario

El usuario busca lograr una mayor autonomía en su vida diaria, logrando desplazarse de manera independiente en silla de ruedas y desenvolverse con mayor independencia o con mínima ayuda en sus actividades cotidianas (AVD). Asimismo, desea mejorar el control de su esfínter y aprender a prevenir y manejar posibles complicaciones relacionadas con su condición. También busca adaptarse de forma positiva a su entorno, fortaleciendo su integración familiar y social. Finalmente, manifiesta interés en recibir orientación sobre sexualidad, tanto a nivel personal como en pareja, con el objetivo de mejorar su bienestar general y su calidad de vida.

g) Referencias bibliográficas

[1] C. L. Crutcher II, J. M. Wilso n, K. D. Morrow, J. A. Shields, L. M. Lassei gn c e, F. Culicchia and G. Tender, "Management of ce rebrospinal fluid leak from cervical gunshot wo un e ds with external ventricular drainage: a small ca se series," Journal of Surgical Case Report s, s vo l. 2020, no. 12, p. rjaa484, Dec. 2020, doi: 10.10 93/jscr/rjaa484. o

[2] I. K. Fox, C. B. Novak, L. C. Kahn, S. E. Mackinnon, R. Ruvinskaya and Nas. Juknis, “Using nerve transfer to restore prehension and grasp 12 years following spinal cord injury e: a case report,” Spinal Cord Series and Cases, vol. 4, p. 37, Apr. 2018, doi: 10.1038/s41394-018-00 67-6.

[3] *ICF Case Studies*, “Peter’s Story,” *Goal-Setting*. Accessed: Apr. 14, 2026. https://www.icf-casestudies.org/case-studies/goal-setting/peter-s-story

[4] World Health Organization, *International Perspectives on Spinal Cord Injury*. Geneva: WHO Press, 2013. [En línea]. Disponible:https://www.who.int/publications/i/item/international-perspectives-on-spinal-cord-injury

[5] Conti A, et al. Barriers and facilitators of education provided during rehabilitation of people with spinal cord injuries. PLoSOne.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33057362/

[6] Jeyathevan G, et al. Facilitators and barriers to supporting individuals with spinal cord injury in the community. Disabil Rehabil. 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30669882/